

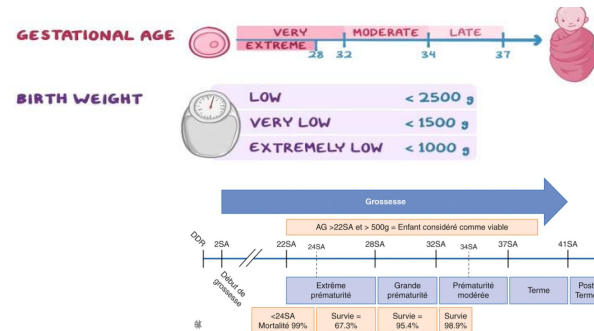
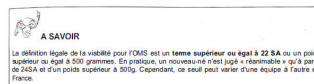
LA MENACE D'ACCOUCHEMENT PREMATURE

OBJECTIFS :

- Définir la menace d'accouchement prématuré.
- Déterminer les facteurs de risques
- Savoir diagnostiquer une menace d'accouchement prématurée.
- Etablir le pronostic
- Savoir conduire un traitement tocolytiques
- Connaître les principes de la prévention et de la prise en charge.

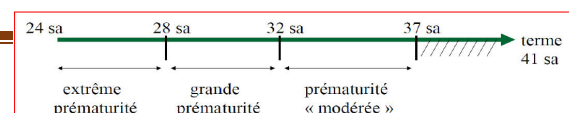
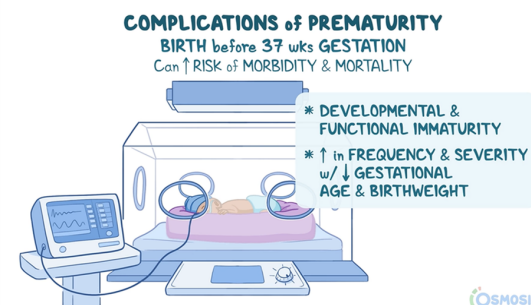
I. INTRODUCTION-DEFINITION

- Définition accouchement prématuré entre 22 et 36SA révolues.
- Véritable problème du sante publique.
- 1ère cause de mortalité et morbidité néonatale: prématurité.
- Meilleur traitement prévention
- Menace d'accouchement prématuré (MAP) :
 - Survenue des CU douloureuses rapprochées persistantes, s'accompagnant d'une modification du col dont l'issue est un accouchement prématuré en l'absence d'intervention médicale



II. EPIDEMIOLOGIE

- Fréquence variable 10-15% grossesses.
- 60% de la pathologie de la grossesse
- 1 ère cause d'hospitalisation pendant la grossesse.
- Le taux de prématurité a peu évolué ces 20 dernières années
 - En France 8,2% en 1972 à 7% en 2003
 - Pays occidentaux : entre 6 et 12% de 2001 à 2005
 - USA : 12.5% (2005)
 - Afrique : 8-10%
- Maîtrise des facteurs de risque et des étiologies
- Problématique de l'élevage du prématuré
 - Cout financier non négligeable de la prise en charge
- Lourde mortalité
- 37% de la mortalité périnatale
- 62% mortalité néonatale précoce
- liée à l'immatunité de certaines fonctions
- Lourde morbidité
 - Détresse respiratoire
 - Infection
 - Séquelles neurologiques (SN) importantes
 - Conséquences d'autant plus graves que de l'âge gestationnel est faible :
 - ✗ Extrême prématurité : entre 24 et 27 SA + 6j (50% SN à 5ans)
 - ✗ Grande prématurité : entre 28 et 32 SA + 6j (36% SN à 5ans)
 - ✗ Moyenne prématurité : entre 33 et 36 SA + 6j (12% SN à 5ans)
- ==> Impératifs d'une bonne prévention et gestion rigoureuse de la MAP



III. PHYSIOPATHOLOGIE



Facteurs mécaniques et infectieux

Surdistension utérine (hydramnios, GG)

Infection/inflammation
Ischémie /collagénase
Cytokines, phospholipides

Production prostaglandines E2

Amincissement des membranes

Contraction

Modification cervicale / hémorragie/RPM

IV. ETIOLOGIES

1. Causes maternelles

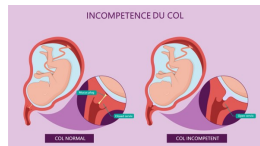
a- Facteurs de risque

- ATCD d'accouchement prématurée
- ATCD d'avortement provoqué ou spontané
- Age <18 ans, >35 ans
- Travail pénible, longs trajets quotidiens
- Enfants à charge, mère célibataire
- Grossesses rapprochées
- Bas niveau socio-économique
- Tabac, toxiques

- Infections : urinaire, cervicovaginale....
- Diabète gestationnel
- Traumatisme abdominale
- Maladies chroniques
- Preeclampsie

c- Causes locales

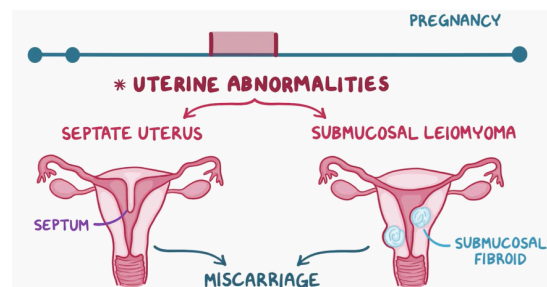
- Malformations utérines
- Béance cervico-isthmique
- Volumineux fibrome endocavitaire



b- Causes générales

2. Causes ovulaires

- Surdistension utérine par grossesses multiples, Hydramnios.
- RPM
- Chorioamniotite.
- Placenta praevia.



V. DIAGNOSTIC POSITIF

- Suppose une datation précise du début de la grossesse (DDR, rapport fécondant, échographie précoce)

A- DIAGNOSTIC CLINIQUE

1. Signes fonctionnels : interrogatoire

- Contractions utérines pathologiques
 - Douloureuses
 - En salves +/- régulières
 - Plus en plus rapprochées.

1-2 chaque 10min avec un facteur déclenchant

- Métrorragies.
- Ecoulement liquide amniotique

2. Examen physique

- Température, TA, pouls
- Hauteur utérine,
- Bruits cardiaques fœtaux
- Spéculum:
 - Métrorragies, Leucorrhée
 - Liquide amniotique, Prélèvements
- Toucher vaginal : score de bishop+++
 - Modifications col: ramollissement, effacement, position, dilatation
 - Descente de la présentation
- NB :
 - Primipare : col long post fermé tonique
 - Multipare : orifice cervical externe perméable

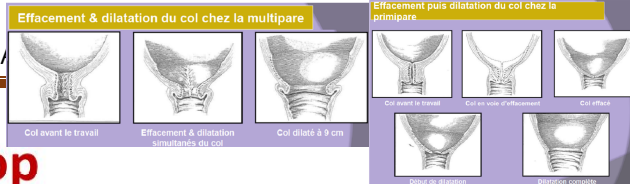


5 critères évalués :

Critère	0	1	2	3
Dilatation (cm)	0	1-2	3-4	≥ 5
Effacement (%)	0-30	40-50	60-70	≥ 80
Consistance	Ferme	Moyenne	Molle	—
Position du col	Postérieur	Mi position	Antérieur	—
Hauteur de la présentation (par rapport aux épineuses sciatiques)	Haute (-3)	Moyenne (-2)	Basse (-1/0)	En appui (+1/+2)
Interprétation :				
Score total	Signification		Conduite à tenir	
≥ 8	Col favorable		Déclenchement possible (travail probable)	
≤ 5	Col défavorable		Préparation cervicale nécessaire (prostaglandines, ballonnet, etc.)	
6-7	Col intermédiaire		Surveillance ou maturation cervicale selon le contexte	



Col de multipare (souriant)



Score de Bishop

	0	1	2	4
Dilatation	fermé	1-2 cm	3-4 cm	≥ 5 cm
Effacement	0-30 %	40-60 %	60-70 %	≥ 80 %
Consistance	ferme	moyenne	molle	-
Position	postérieure	centrale	antérieure	-
Présentation	mobile	amorcée	fixée	engagée

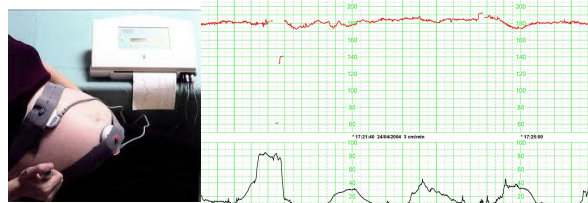
- La rupture prématurée des membranes
 - Tournant décisif: risque infectieux et risque d'accouchement
 - Entre 50 et 90 % des patientes entrent en travail spontanément dans la semaine suivant la RPM
- Hospitalisation obligatoire et éviter les TV répétés

B- DIAGNOSTIC PARACLINIQUE

1. Diagnostic positif de MAP:

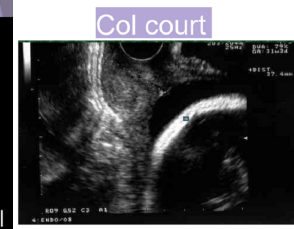
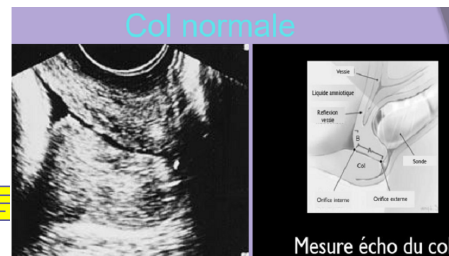
• Electrique:

- Enregistrement tocographique :
 - × Fréquence,
 - × Durée
 - × Intensité
- TOCOGRAPHIE CARDIOTOGRAPHIE
- Pratiquée chez une patiente symptomatique
- Pour apprécier intensité et rythme des CU
- Pour évaluer l'efficacité d'une tocolyse
- Surveiller la dynamique utérine



• Echographique:

- Echographie cervicale endovaginale:
 - × Longueur du col (risque si <25 mm)
 - × Entonnoir.
 - × Protrusion des membranes.



• Biologique: actualité

• Recherche de la fibronectine sur un PV

• Glycoprotéine normalement absente dans sécrétions cervicovaginales entre la 21ème et la 37ème semaine

EN SOMME,

- Devant des symptômes le TV demeure l'examen de référence
- L'échographie est un examen de deuxième ligne permettant de « chiffrer » les modifications cervicales dont la LC (20-30 mm) avec un seuil de LC 26 mm (VPN >90%)
- La fibronectine, peut être utilisée pour une LC entre 15 et 26 mm car si FBN négative on peut éviter l'hospitalisation (car VPN 96 à 99%)

2. Diagnostic étiologique

- Bilan infectieux :
 - × ECBU, prélèvement vaginal (Systématique)
 - × NFS, CRP hémoculture +/-
- Echographie utérine
- Participe à la recherche étiologique (GG malformation utérine, fibrome, PP...)
- Etudie le fœtus (estimation poids fœtal bien-être fœtal, les mouvements respiratoires...)
- Etudie les anomalies du LA après rupture des membranes

VI. PRONOSTIC ET SURVEILLANCE

- Clinique (Douleur, les CU, écoulement vaginal...)
- Echographie 
- Cardiotocographie+++
- CRP, NFS, PV, ECBU

**LES FACTEURS DU PRONOSTIC → SCORE D
TOCOLYSE (= élément de décision et de gravité.)**

Score de tocolyse de Baumgarten,

	0	1	2	3	4
CU	0	Irrégulières	Régulières		
Membranes	Intactes		Rupture Haute		Rupture Basse
Métrorragies	0	Minimes		Massives	
Dilatation	0	1 cm	2 cm	3 cm	> 4 cm

Tenir compte du terme gestationnel, des résultats de l'échographie et du score :

- Score 3 Menace légère; → Repos, traitement ambulatoire
- Score 4-6 Menace modérée: → Tocolyse active
- Score 7: Menace sévère → Préparer l'accouchement, transfert

VII. DIAGNOSTICS DIFFERENTIELS

- Douleurs ligamentaires: syndrome de Lacomme. 
- Contractions physiologiques.
- Utérus contractile

VIII. PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE

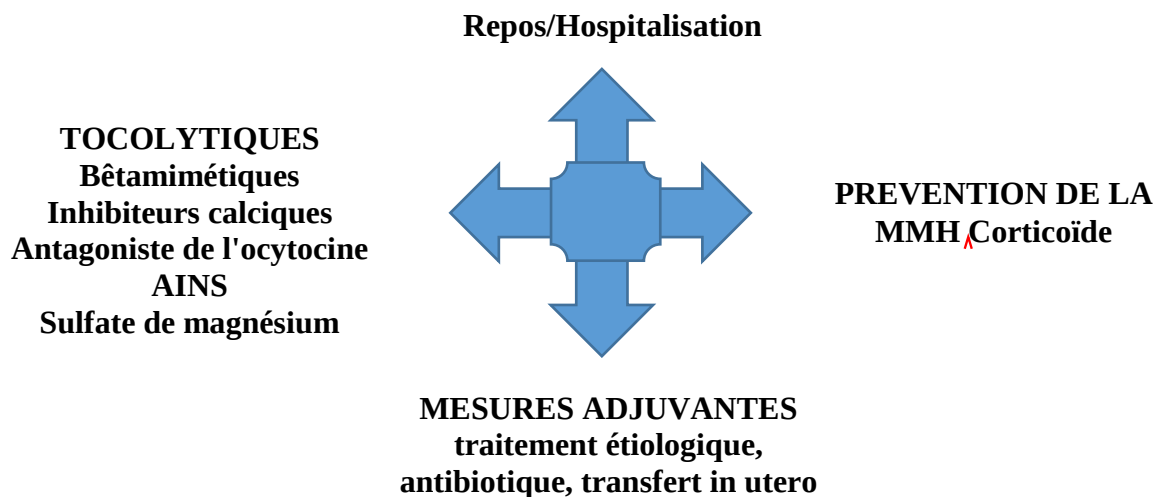
- Transfert in utero. 
- Corticothérapie.

BUTS

- Stopper la menace d'accouchement prématuré
- Eviter l'évolution vers l'accouchement prématuré
- Prévenir les complications de la prématurité

PRINCIPES

- Arrêt de l'activité physique et repos Inhibition pharmacologique de la contraction utérine
- Identification et traitement adapté de l'étiologie
- Prévoir les conséquences de l'échec de la tocolyse



1. Repos :

- Arrêt travail ou hospitalisation en fonction gravité MAP

2. Traitement du facteur déclenchant éventuel.

3. Médicaments Tocolytiques:

- B2 mimétiques
- Inhibiteurs calciques
- Antagoniste de l'ocytocine
- Autres: Progestatifs, Antispasmodiques, AINS, Sulfate de magnésium

4. Corticothérapie

A. Tocolytiques

- But: corticothérapie.
- Contres indications des Tocolytiques:
- Fœtales: Malformations létales, Souffrance fœtales aigue
- Maternelles :
 - Preeclampsie
 - Chorioamniotite
 - Cardiopathie, hyperthyroïdie et diabète mal équilibré

Bilan préthérapeutique

- Auscultation cardiaque et ECG
- Glycémie et kaliémie
- Créatininémie

Surveillance étroite

- De l'efficacité CU.
- De la tolérance maternelle pouls, TA, dyspnée, auscultation pulmonaire, tremblements.
- Du bien être fœtal RCF

Durée de tocolyse: courte, 5 jours n'en moyenne pas de bénéfice pour la prolongation

1. B MIMÉTIQUES

- Substances β adrénergique non sélectifs
- Effets secondaires tachycardie, hypokaliémie hyperglycémie
- Mode d'administration :
 - Intraveineux en perfusion,
 - 24h à 48h
 - Relais par voie orale 30mn avant arrêt perfusion
 - Utile dès 20 SA
 - Surveillance clinique et paraclinique

2. INHIBITEURS CALCIQUE

Effacité = b mimétiques pour prolonger la grossesse.

- Nifedipine ++ (adalate).
- Effets secondaires moindres.
- TTT d'attaque: adalate simple: 1 cp/15 min pendant 1 heure.
- TTT d'entretien: 1 cp/8h pd 5jours

3. Antagoniste de l'ocytocine

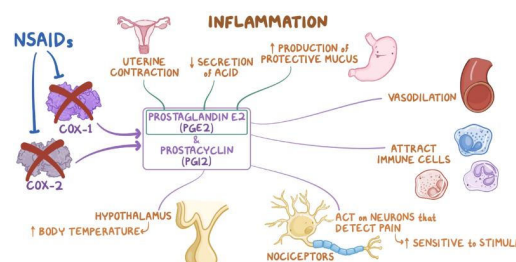
- Atosiban : (tractocile).
- Très utilisé en France.
- Efficacité comparable aux B mimétiques.
- Pas de contre-indication.
- Effets secondaires mineurs.
- Problème: cout

4. LES ANTIINFLAMMATOIRES

- Action antiprostaglandine
- Indométacine 175mg/j
- Effets secondaires+++
 - Oligoamnios par diminution filtration glomérulaire
 - Fermeture prématuré canal artériel

Lorsqu'une tocolyse est indiquée chez la femme en travail prématuré, **les inhibiteurs calciques** sont préférables aux autres médicaments tocolytiques qui leur ont été comparés, principalement les bêtamimétiques

Lorsqu'une tocolyse est indiquée chez la femme en travail prématuré, **les inhibiteurs calciques et l'atosiban** sont préférables aux autres médicaments tocolytiques qui leur ont été comparés.



5. AUTRES:

- Progestatifs: effet myorelaxant.
- Aucune efficacité démontrée.
- Antispasmodiques efficacité non démontrée.
- Ethanol n'est plus utilisé.
 - Détresse respiratoire.
- Sulfate de magnésium
 - Action plaque neuromusculaire
 - Tocolyse rapide, courte
 - Anglo-saxons Hypocalcémie et hypomagnésémie néonatale

Lorsqu'une tocolyse est indiquée chez la femme en travail prématuré, les inhibiteurs calciques sont préférables aux autres R médicaments tocolytiques qui leur ont été comparés, principalement les bêtamimétiques

Le traitement tocolytique ne permet PAS De prolonger la grossesse D'empêcher l'accouchement prématuré D'améliorer le pronostic néonatal

MAIS

**Le traitement tocolytiques permet d'effectuer : Une cure anténatale de corticoïdes
Un transfert in utero vers un centre adapté**

Le traitement tocolytique ne permet PAS
De prolonger la grossesse
D'empêcher l'accouchement prématuré
D'améliorer le pronostic néonatal

Mais

Le traitement tocolytique permet
D'effectuer une cure anténatale de corticoïdes
Transfert in-utero vers un centre adapté

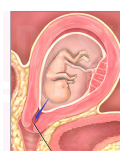
QE!!

B. CORTICOTHERAPIE

- Avant 34 SA
- Accélération maturation pulmonaire.
- Bétaméthasone
 - **Célestène***
 - 12mg IM à répéter dans 24H pendant 48h
 - Contre-indication infection maternelle ou fœtale
- A faire de 24-25SA à 34SA, à répéter à 15 j d'intervalle.
- Bénéfice prouvé pour 1 à 2 cures anténatales
- Si 3 cures de corticoïdes anténatales à 3 ans.
 - Troubles cognitifs
 - Troubles mnésiques
 - Hyperactivité

C. AUTRES MESURES

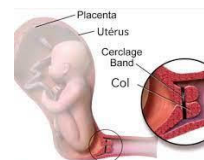
- **Antibiotiques**
 - Oui, car lien entre Accouchement prématuré e
 - × Infection urinaire (ECBU et traitement)
 - × Infection cervico-vaginale (risque de chorioamniotite infra-clinique dans 60 et 75% des cas) A traiter par Amoxicilline 2gr/j ou érythromycine 2gr/ j
 - En dehors infection urinaire ou cervico-vaginale et à membranes intactes: pas de prescription systématique.
- **Place du cerclage tardif**
 - Rôle préventif strict
 - Aucun rôle devant la menace aigue /// geste risqué
- **Le pessaire; une nouveauté?!**
 - Un pessaire en silicone pourrait efficacement retarder l'accouchement prématuré chez 94% femmes à risque. Cette étude espagnole, dont les conclusions sont publiées dans l'édition du 3 avril du Lancet montre que le taux de prématurité chez les femmes enceintes à risque accru peut être réduit de 27% à 6% grâce à ce dispositif médical en forme d'anneau, très peu coûteux. Et 95% des femmes qui l'ont porté, pourraient le recommander.
- **Autres mesures accouchement prématuré inéluctable**
 - Accouchement et accueil du prématuré (mesures obstétricales et néonatales)



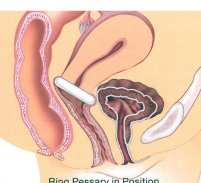
Un col ouvert



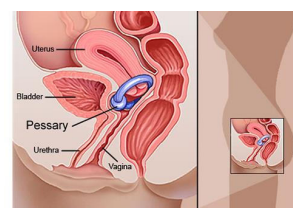
Cerclage



Dr Hicham MARGAL / Gynécologue - obstétricien



Ring Pessary in Position



IX. EVOLUTION

- **Favorable**
 - Arrêt des contractions, stabilisation des modifications cervicales et poursuite de la grossesse 15 jours surtout si :
 - × Tocolyse efficace
 - × Étiologie bien prise en charge
- **Récidive**
 - Possible si
 - × Étiologie non ou mal traitée
 - × facteurs de risque non pris en compte dans la consolidation du traitement
- **Défavorable**
 - vers l'accouchement prématuré inéluctable d'autant que: cliniquement: le score de tocolyse est élevé(TV) 
 - À l'échographie que la LC est k 15 mm 
 - Une recherche de fibronectine est positive
 - Inefficacité de la tocolyse et étiologie non traitée
 - Signes d'alarme présents (pré éclampsie sévère décollement placentaire, infection intra-utérine)

X. PRÉVENTION DE LA M.A.P

- Planification familiale
- Dépistage et suppression des facteurs de risques
- Multiplication des consultations prénatales
- Visites à domicile (sages-femmes)
- Repos à domicile, Congé prénatal
- Hospitalisation
- Traitement des anomalies du contenant
- Cerclage /BCI

XI. CONCLUSION

- FREQUENTE.
- DEPISTAGE FACTEURS RISQUE
- PRISE EN CHARGE ADAPTEE
- ACCOUCHEMENT PREMATURE.
 - MORTALITE, MORBIDITE+++